



DOSSIER CLÍNICO: INFECCIONES BACTERIANAS *DE LA PIEL*

Topografía, Fisiopatología y Manejo Terapéutico.

Alto Rendimiento | Dermatología

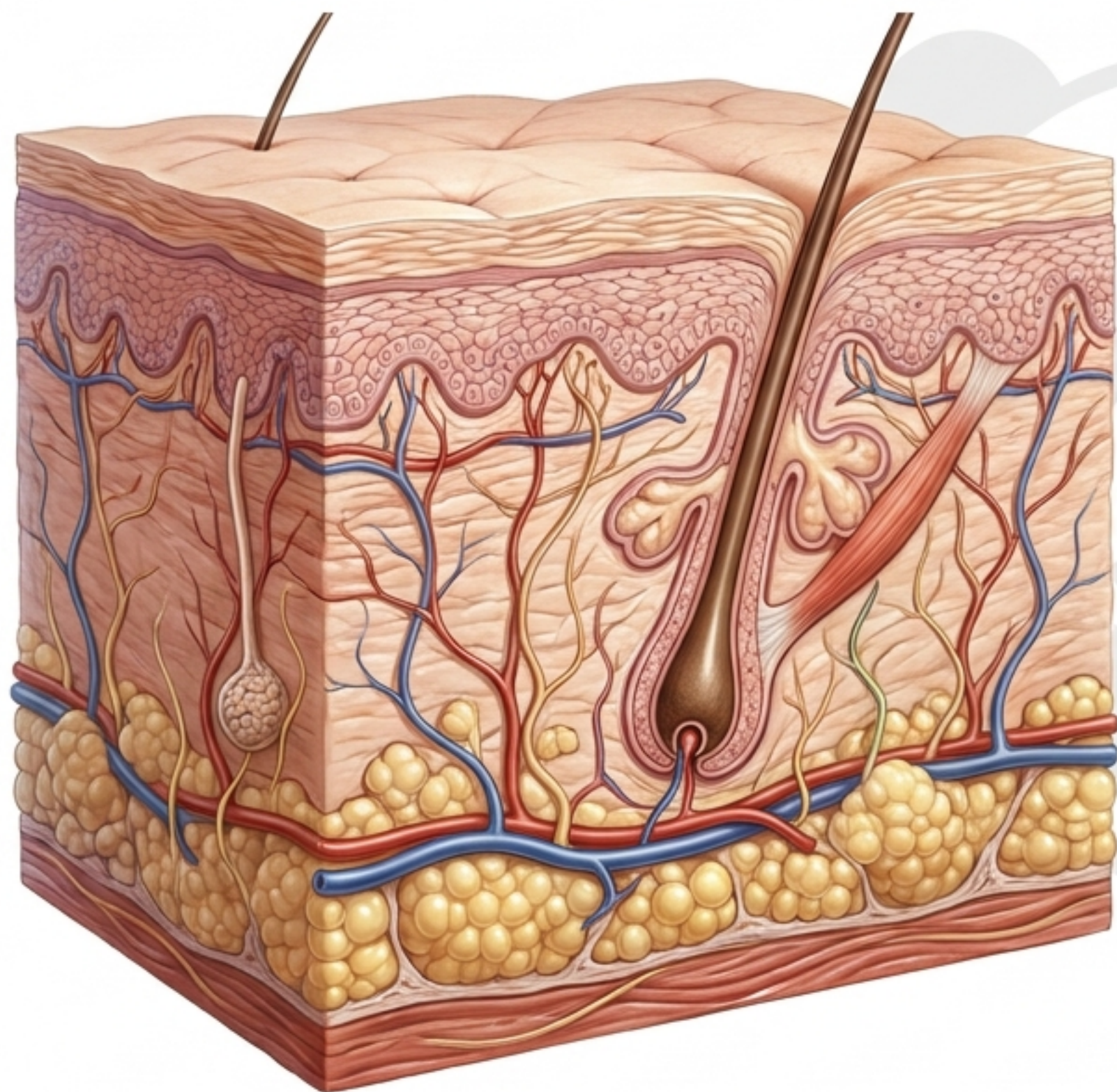


BADBEAR.MED

Síguenos en:  Facebook •  Instagram •  YouTube •  Rutube •  OnlyFans •  Telegram •  TikTok

Gemini Notebook

TOPOGRAFÍA INFECCIOSA: MAPEO POR ESTRATOS

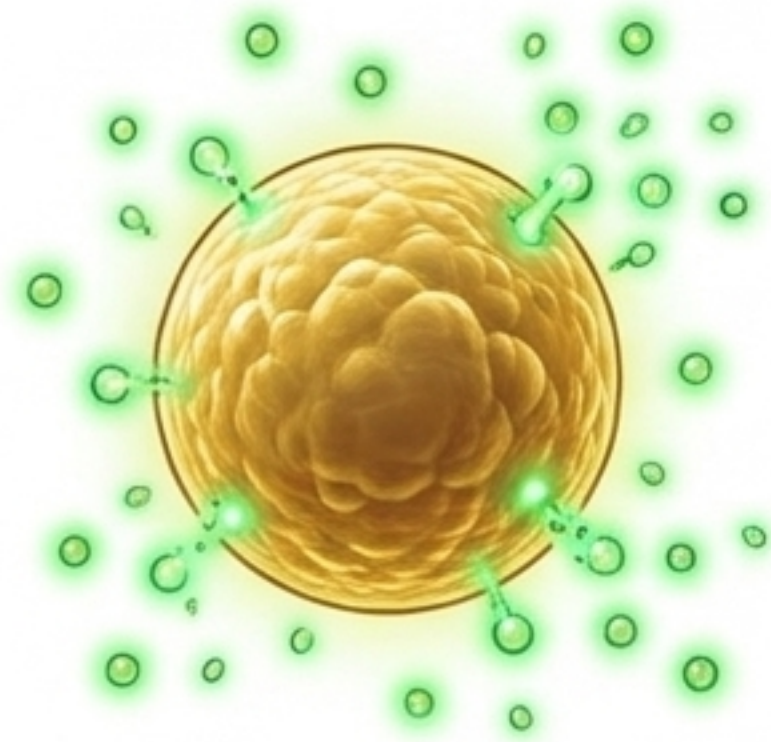


IMPÉTIGO (Vulgar y Ampollar)
Infección intraepidérmica superficial.

ECTIMA
Infección dérmica profunda (úlceras).

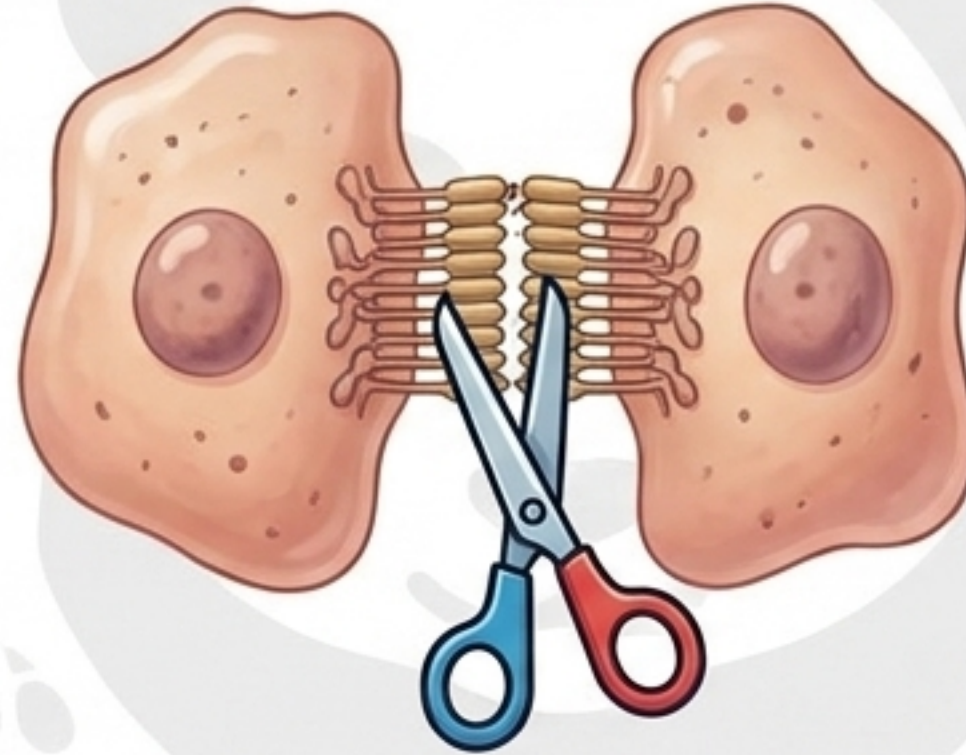
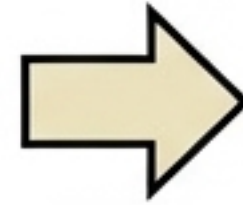
ESPECTRO FOLICULAR
Superficial: Folliculitis
Profundo: Forúnculo / Ántrax

MECANISMO DE ACANTÓLISIS ESTAFILOCÓCICA



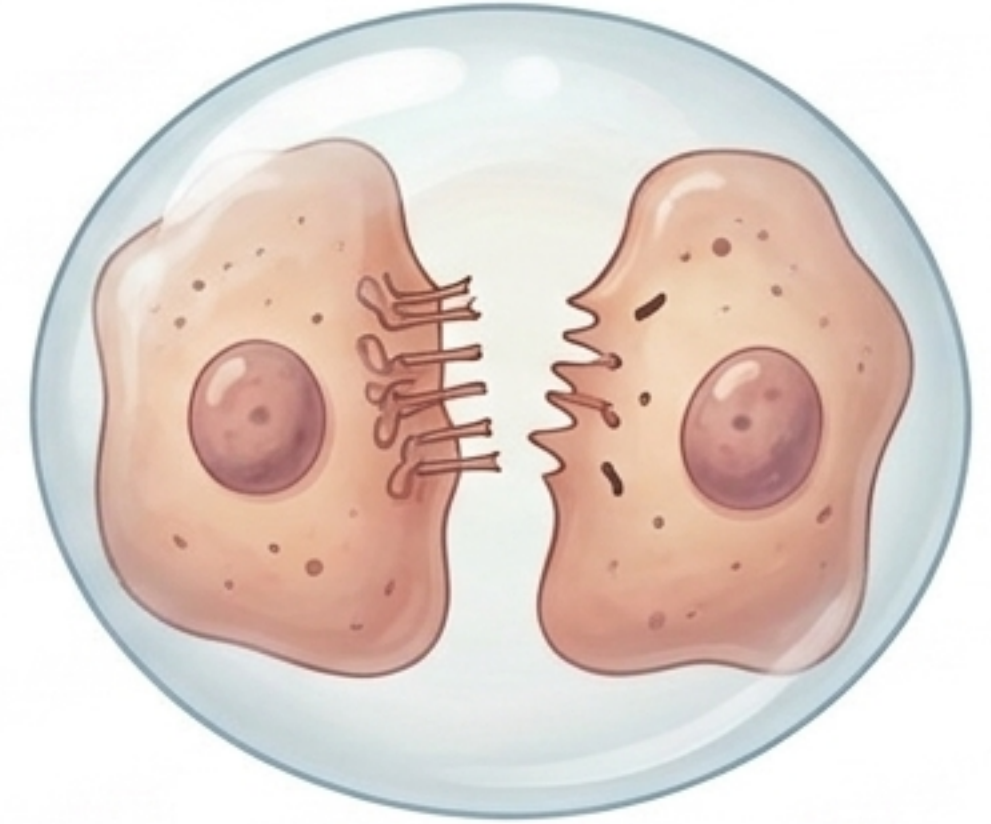
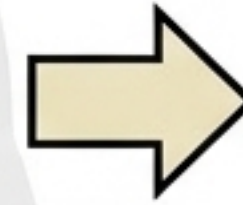
Paso 1

S. aureus produce
Toxinas Exfoliativas A y B.



Paso 2

Las toxinas actúan específicamente
escindiendo la Desmogleína-1
(proteína estructural de los
desmosomas en la piel).



Paso 3

Destrucción de puentes
intercelulares = Acantólisis.
Formación de ampolla flácida
intraepidérmica.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: IMPÉTIGO

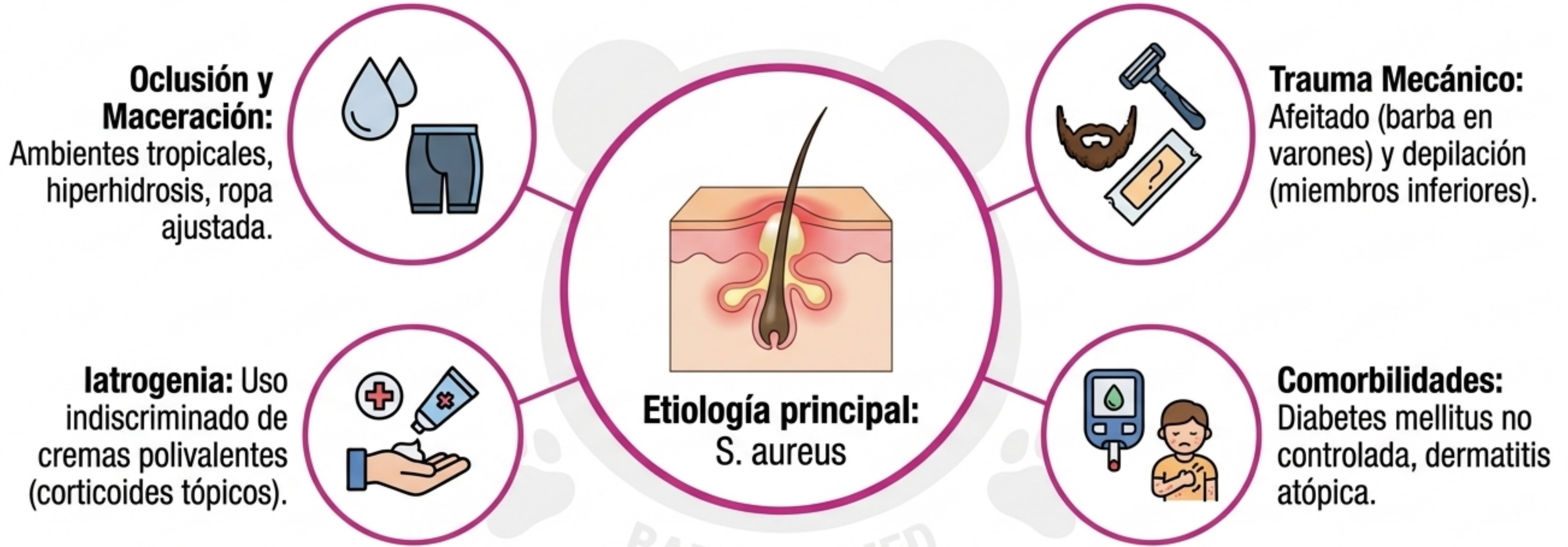
Característica	Impétigo No Ampollar (Vulgar)	Impétigo Ampollar
Epidemiología	Más frecuente. Preescolares.	Neonatos y lactantes pequeños.
Lesión Elemental	 Pápulas/vesículas que evolucionan a costras melicéricas (color miel).	 Ampollas flácidas grandes que se rompen rápidamente.
Distribución	Periorificial (nariz, boca, orejas). Diseminación por autoinoculación.	Zonas intertriginosas (pliegues). Diseminación rápida.
Clínica Sistémica	Prurito, adenopatías regionales. Curso benigno.	Generalmente sin compromiso sistémico, pero requiere vigilancia en neonatos.

ECTIMA: LA INFECCIÓN DÉRMICA PROFUNDA



- ⚠ **Etiología:** Primariamente *S. pyogenes* (frecuentemente sobreinfectado por *S. aureus*).
- ⚠ **Morfología:** Costra hemorrágica adherida. Al retirarse, revela una úlcera en sacabocado con base necrótica y purulenta.
- ⚠ **Topografía:** Extremidades inferiores (usualmente <10 lesiones).
- ⚠ **Factores de Riesgo:** Inmunosupresión, linfedema, dermatosis neglecta (higiene deficiente), picaduras de insectos, traumatismos previos.
- ⚠ **Diferencial Crítico:** Necesaria biopsia/cultivo para descartar ectima gangrenoso o vasculitis cutánea ulcerativa.

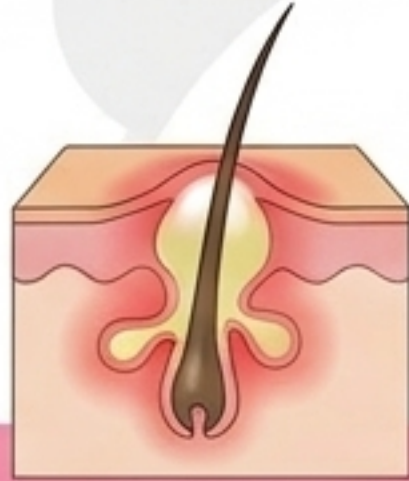
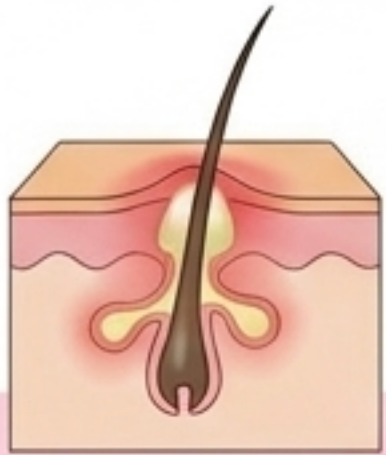
FOLICULITIS: INFLAMACIÓN DEL OSTIUM FOLICULAR



Variante Pediátrica: Impétigo de Bockhart

Foliculitis superficial infantil. Pústulas diminutas (1-4 mm) aglomeradas, típicamente en cuero cabelludo. Cura sin dejar cicatriz.

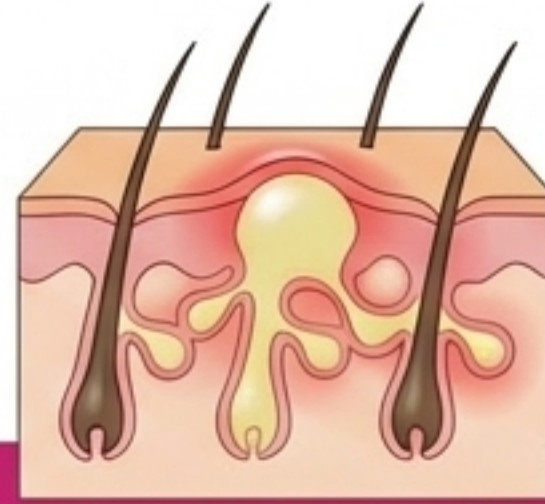
ESPECTRO DE GRAVEDAD FOLICULAR



Nivel 2: Forúnculo (Profundo)

Anatomía: 1 folículo entero + tejido blando circundante.

Clínica: Nódulo eritematoso, caliente, muy doloroso y fluctuante. Deja cicatriz.



Nivel 3: Ántrax / Carbunco (Confluyente)

Anatomía: Fusión de múltiples folículos infectados adyacentes.

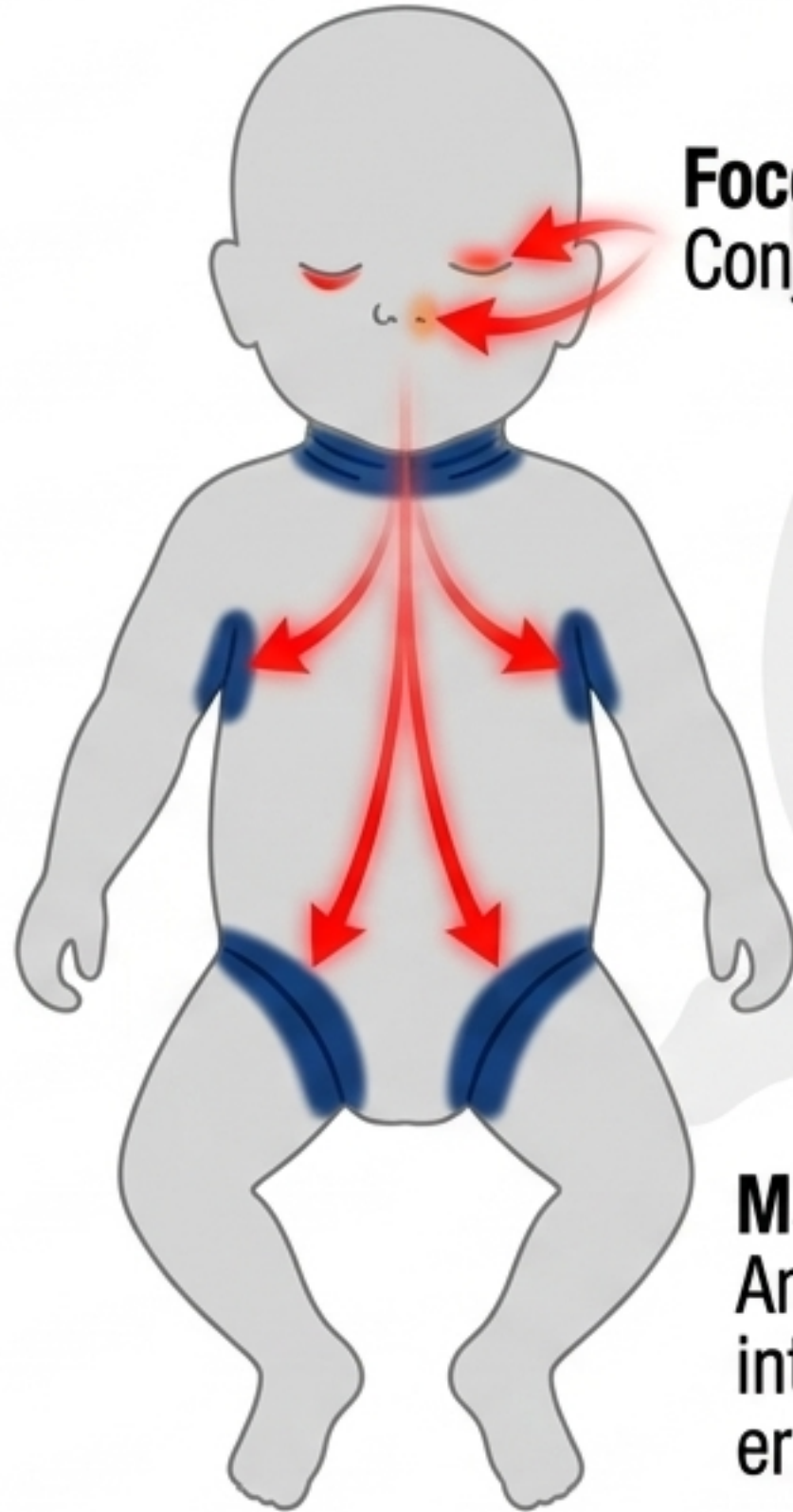
Clínica: Gran placa inflamatoria con múltiples puntos de supuración. Requiere drenaje y antibiótico sistémico.

Nivel 1: Foliculitis (Superficial)

Anatomía: 1 folículo (porción superficial).

Clínica: Pápula o pústula eritematosa. Pruriginosa. Sin cicatriz.

SÍNDROME DE PIEL ESCALDADA ESTAFILOCÓCICA (SSSS)



Focos primarios ocultos:
Conjuntivitis purulenta, rinorrea

Diseminación:
Vía hematógica de
toxinas exfoliativas A/B

Manifestación:
Ampollas flácidas en zonas
intertriginosas y pliegues. Piel
eritematosa e hipersensible.

TARJETA DE ALERTA CLÍNICA

Población Diana:
Neonatos y lactantes (ligero
predominio en varones).

Mortalidad Diferencial:
~3% en población pediátrica vs.
>50% en adultos mayores o
inmunosuprimidos.

Clínica Sistémica:
Fiebre, irritabilidad extrema,
rechazo al alimento.
¡Riesgo de septicemia!

ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA

Evaluación del Paciente
(Extensión, Edad,
Estado Inmunológico)

Lesiones **localizadas**
+ Inmunocompetente
+ Buena higiene

Lesiones extensas / Ampollares /
Inmunosupresión / **Menores
lactantes** (SSSS, Ántrax)



Manejo Tópico (Primera Línea):

- Mupirocina 2%
- Ácido Fusídico 2%
- Medidas adjuvantes: Limpieza diaria, remoción de costras, jabones suaves (ej. Clorhexidina).

Manejo Sistémico (Vía Oral / IV):

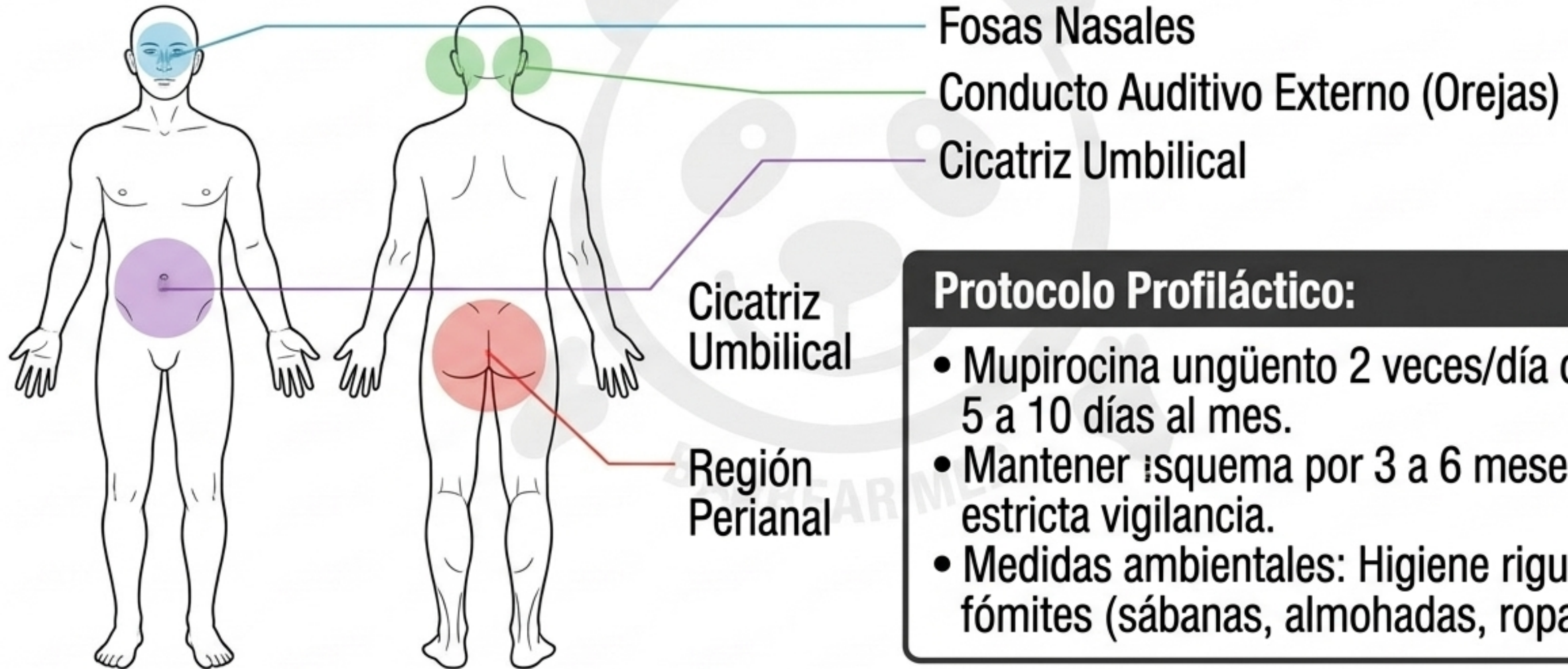
- Cefalosporinas (ej. Cefalexina)
- Dicloxacilina
- Doxiciclina (elección en foliculitis/forunculosis recurrente)



Nota Quirúrgica: Incisión y drenaje obligatorio en abscesos/ántrax + compresas tibias iniciales.

MANEJO DE LA RECURRENCIA Y DESCOLONIZACIÓN

Pacientes con >5-6 episodios anuales de foliculitis/forunculosis requieren protocolo de erradicación del estado portador de *S. aureus*. Descartar siempre Diabetes Mellitus oculta.



Protocolo Profiláctico:

- Mupirocina ungüento 2 veces/día durante 5 a 10 días al mes.
- Mantener isquema por 3 a 6 meses bajo estricta vigilancia.
- Medidas ambientales: Higiene rigurosa de fómites (sábanas, almohadas, ropa).